

Оценка показателей заболеваемости и смертности от рака шейки матки в Республике Казахстан за 2004- 2014 годы

Аннотация. Произведена оценка показателей заболеваемости раком шейки матки за последние 10 лет. Территориальные, временные и по возрасту особенности РШМ изучали с помощью возрастных интенсивных и стандартизованных показателей на 100 тыс. женского населения. В Республике Казахстан показатели заболеваемости колеблются от 17‰ до 20‰ женского населения, приведенного по возрасту к мировому стандарту World. В 2004 году показатели заболеваемости составили 14,5 на 100 000 женского населения, а в 2014 году 20,2 на 100 000 женского населения. Пик заболеваемости за последние 6 лет сместился к более молодому возрасту, общее увеличение заболеваемости произошло за счет женщин в возрасте от 35 до 55 лет. При анализе рака шейки матки в разрезе стадий отмечается увеличение частоты выявления данного заболевания в первой стадии за период с 2004 по 2014 годы

Ключевые слова: рак шейки матки, заболеваемость, смертность, Республика Казахстан.

Рак шейки матки относится к социально значимым проблемам современного мира, является одной из лидирующей причины смертности женщин в самом активном возрасте, в развивающихся странах. Злокачественное новообразование шейки матки по данным Globocan 2012 занимает четвертое место среди онкологических заболеваний у женщин и седьмое место среди всех злокачественных новообразований. Только за 2012 год было выявлено 528,000 новых случаев рака шейки матки. В более чем в 85% случаев рак шейки матки выявляется в развивающихся странах, где треть всех женщин выявляется в запущенной стадии заболевания. На сегодняшний день, существующие методы первичной профилактики оказывают влияние на динамику развития рака шейки матки, отмечается тенденция к уменьшению, но в ряде стран сохраняется тенденция к росту заболеваемости злокачественными новообразованиями шейки матки [1, 2].

В Республике Казахстан показатели заболеваемости колеблются от 17‰ до 20‰ женского населения, приведенного по возрасту к мировому стан-

дарту World. Во многих европейских странах показатели в 2-3 раза ниже этих значений. Показатели с низкими уровнями заболеваемости находятся на северо-американском континенте, в странах западной Европы. Казахстан входит в группу с высоким показателем заболеваемости, включающие такие страны как Латвия, Литва, Украина, Россия и близлежащие страны Средней Азии. Прогнозные данные ВОЗ, Globocan 2012 выше показателей канцер-регистра Республики Казахстан, при этом отмечается небольшая разница показателей смертности между прогнозными данными Globocan 2012 и реальными данными канцер – регистра. Это связано с сохраняющимися темпами роста заболеваемости за последние 10 лет [3, 4].

Показатели смертности от рака шейки матки также имеют существенные отличия по странам, как и показатели отношения смертности к заболеваемости. Данный показатель очень высок в Казахстане (41,3‰), что в полтора-два раза выше чем в Дании (17,9‰), Германии (20,7‰), Финляндии (23,3‰), но ниже чем в Кыргызстане (47,3‰) и Индии (56,8‰). Данные высокие показатели характеризуют о серьезности и актуальности проблемы по раннему выявлению и лечению злокачественных новообразований шейки матки. Показатели смертности также имеют существенные различия по странам: от 1,0‰ среди женского населения в Финляндии до 12,43‰ среди женского населения в Индии, также как и отношении смертности к заболеваемости. В Казахстане злокачественные новообразования шейки матки среди злокачественных опухолей занимают 5 ранговую позицию и десятое место по смертности в общей популяции. Только 2014 году доля злокачественных новообразований шейки матки в общей заболеваемости онкологической патологией составила 5,1% [3, 4].

Эпидемиологические данные об уровнях заболеваемости злокачественными новообразованиями шейки матки показывают существенные различия по странам: от 3,6 на 100 000 женщин в Швейцарии до 26,1 на 100 000 женщин в Литве [1, 2] (таблица 1)

Таблица 1- Заболеваемость злокачественными новообразованиями шейки матки и смертность от них в отдельных странах мира в 2012 году (на 100 000 женского населения, мировой стандарт World, данные GLOBOCAN 2012)

Страны	Заболеваемость	Смертность	Отношение смертности к заболеваемости, %
Республика Казахстан*	29,4	9,8	33,4
Республика Казахстан**	18,7	7,7	41,2
Республика Казахстан***	17,9	7,4	41,3
Азербайджан	9,8	3,9	39,8
Беларусь	13,2	4,7	35,6
Кыргызстан	23,7	11,2	47,3
Российская Федерация	15,3	6,1	39,9
Узбекистан	13,5	6,4	47,3
Украина	16,6	6,4	38,6
Великобритания	7,1	1,8	25,4
Германия	8,2	1,7	20,7
Дания	10,6	1,9	17,9
Латвия	17,3	6,3	36,4
Литва	26,1	7,5	28,7
Нидерланды	6,8	1,6	23,5
Польша	12,2	5,4	44,3
Словакия	16,1	5,2	32,3
Финляндия	4,3	1,0	23,3
Франция	6,8	1,9	27,9
Швейцария	3,6	1,1	30,6
Швеция	7,4	1,9	25,7
Индия	22,0	12,4	56,8
Китай	7,5	3,4	45,3
Корея	9,5	2,5	26,3
Япония	10,9	2,8	25,7
Австралия	5,5	1,6	29,1
Бразилия	16,3	7,4	45,4
Канада	6,3	1,7	27,0
США	6,6	2,7	40,9
Примечания:* по данным ВОЗ, GLOBOCAN 2012 ** по данным ЭРОБ РК, интенсивные (грубые) показатели *** по данным ЭРОБ РК, стандартизованные показатели			

При анализе грубых интенсивных показателей заболеваемости раком шейки матки отмечается увеличение частоты выявления данного заболевания за период с 2004 по 2014 годы (рисунок 6.1). В 2004 году показатели заболеваемости составили 14,5 на 100 000 женского насе-

ления, а в 2014 году 20,2 на 100 000 женского населения. Аналогичную тенденцию подтвердили и стандартизованные показатели. Резкое увеличение заболеваемости связано с увеличением выявления рака шейки матки с введением скрининговой программы.

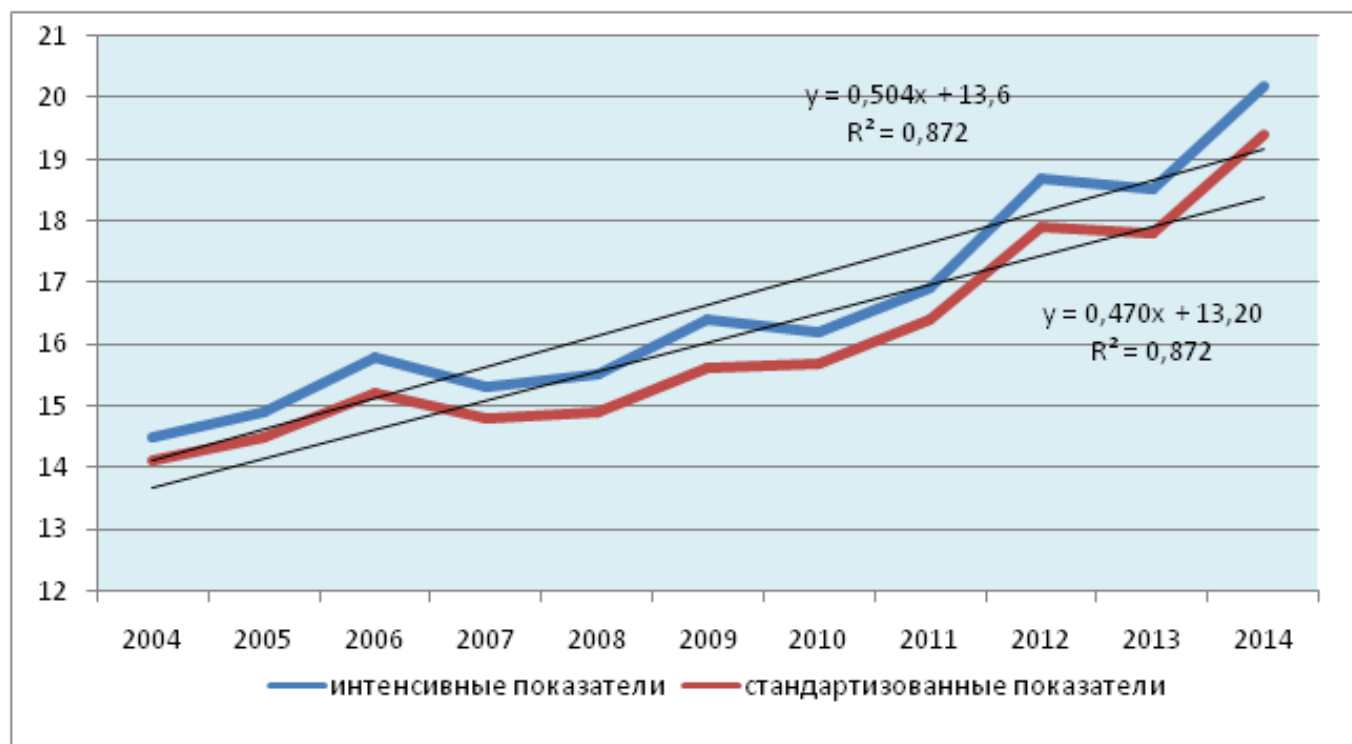


Рисунок 1 - Динамика интенсивных и стандартизованных World показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями шейки матки на 100 000 женского населения РК за период 2004-2014гг

Проведенный анализ возрастных показателей заболеваемости (рисунок 6.2) выявил значительный риск заболевания уже в молодом возрасте и заметное увеличение его к 40-44 годам. Пик заболеваемости за последние 6 лет сместился к более молодому возрасту, общее

увеличение заболеваемости произошло за счет женщин в возрасте от 35 до 55 лет. Возрастное распределение подтверждает необходимость совершенствования и усиления скрининга среди женщин молодого и среднего возраста.

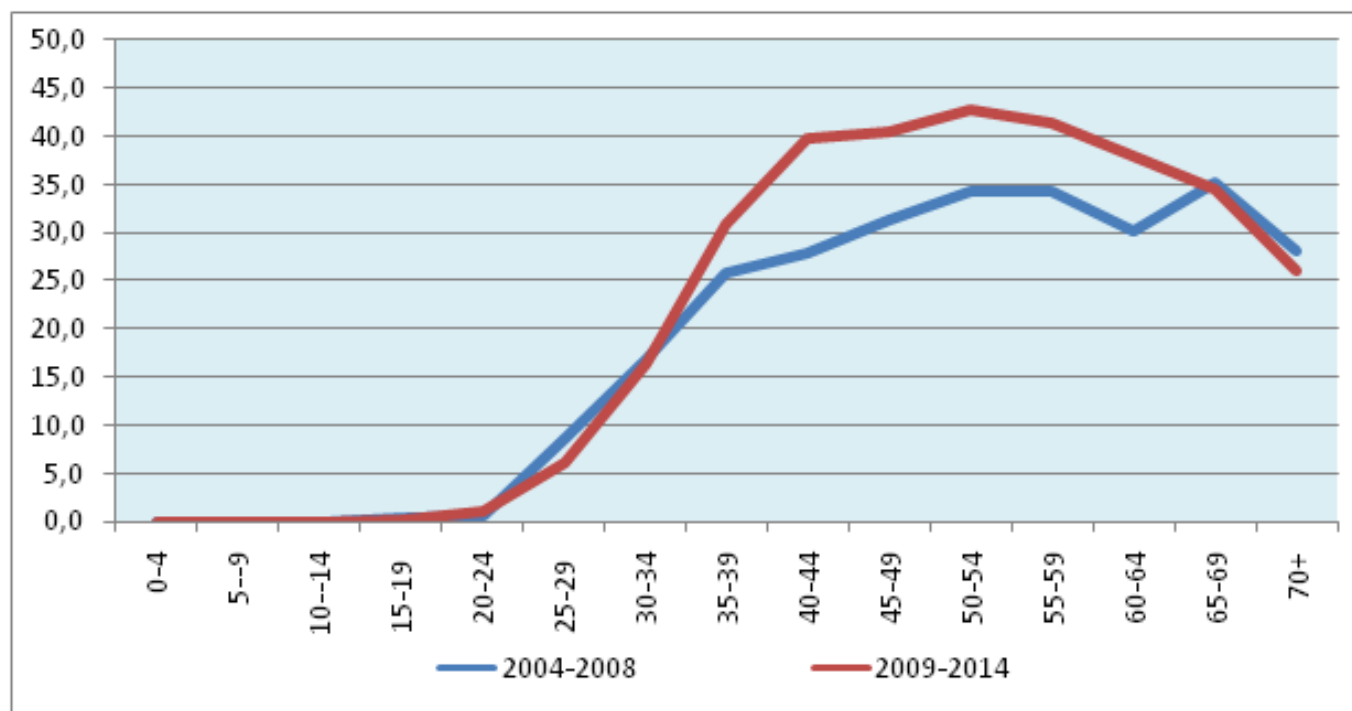


Рисунок 2 - Возрастные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями шейки матки женщин Республики Казахстан (средние показатели на 100 000 женского населения соответствующего возраста за 2000- 2008 и 2009-2014годы)

В частоте первичного рака шейки матки также имеются определенные различия по территориальному признаку (рисунок 6.3). Анализ первого пятилетнего периода показал высокие показатели заболеваемости в Атырауской, Костанайской, Павлодарской и Актюбинской областях, данные показатели были выше среднереспубликанских показателей. За последние 6 лет самые

высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в г.Алматы, Костанайской и Атырауской областях, а самые низкие показатели в Южных регионах Казахстана: в Южно-Казахстанской, Жамбылской и Кызылординской областях (статистически значимые отличия от среднереспубликанских значений).

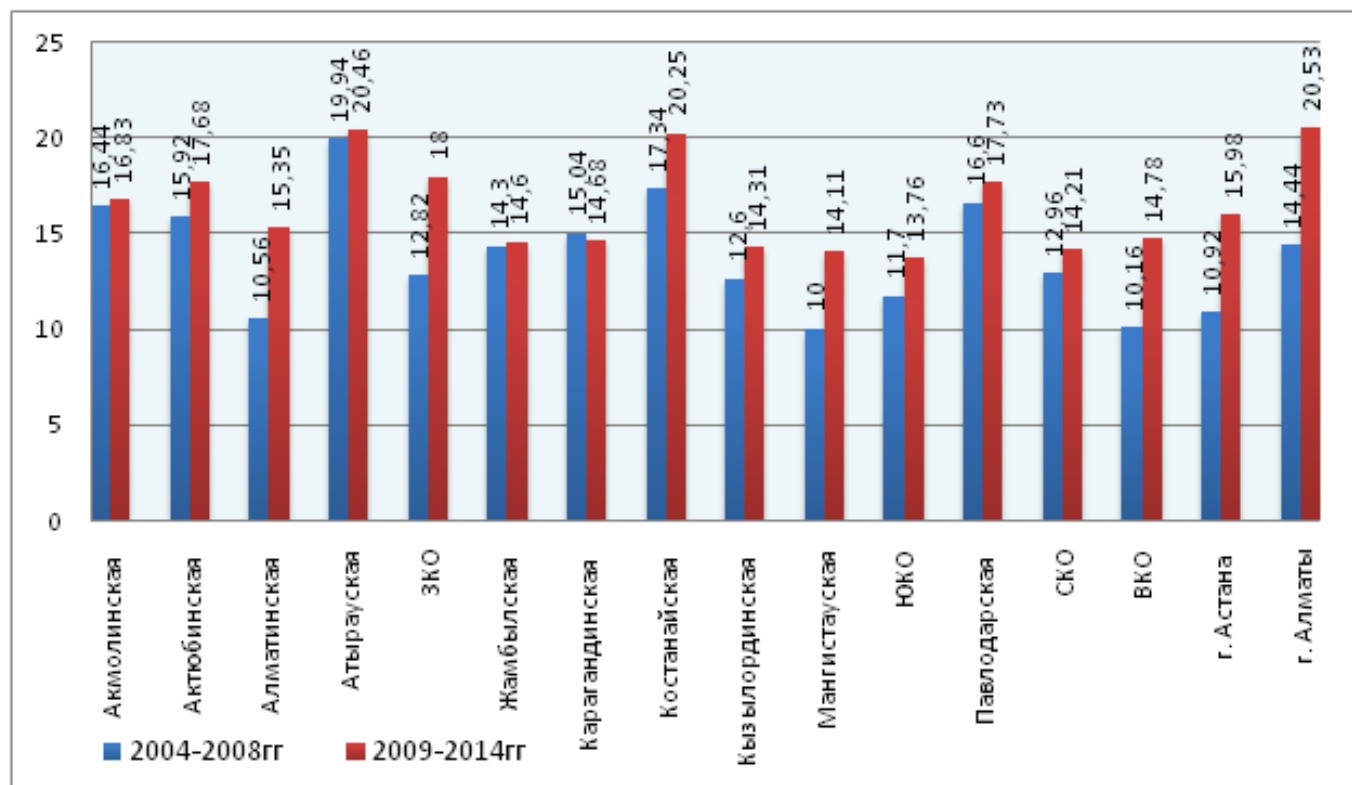


Рисунок 3 - Территориальные уровни заболеваемости женщин Республики Казахстан злокачественными новообразованиями шейки матки (средние стандартизованные показатели World на 100 000 женского населения) за 2004-2008 и 2009-2014 годы

При анализе рака шейки матки в разрезе стадий отмечается увеличение частоты выявления данного заболевания в первой стадии за период с 2004 по 2014 годы (рисунок 6.4). В 2004 году было выявлено 735 женщин с злокачественными новообразованиями шейки матки в первой стадии, а в 2014 году 1467 женщин, что составляет двукратное увеличение выявления рака шейки матки.

Данная тенденция связана с успешным внедрением национальной скрининговой программы раннего выявления рака шейки матки. Также можно заметить снижение обнаружения рака шейки матки в третьей стадии, что нельзя сказать об обнаружении данной патологии в запущенной форме.

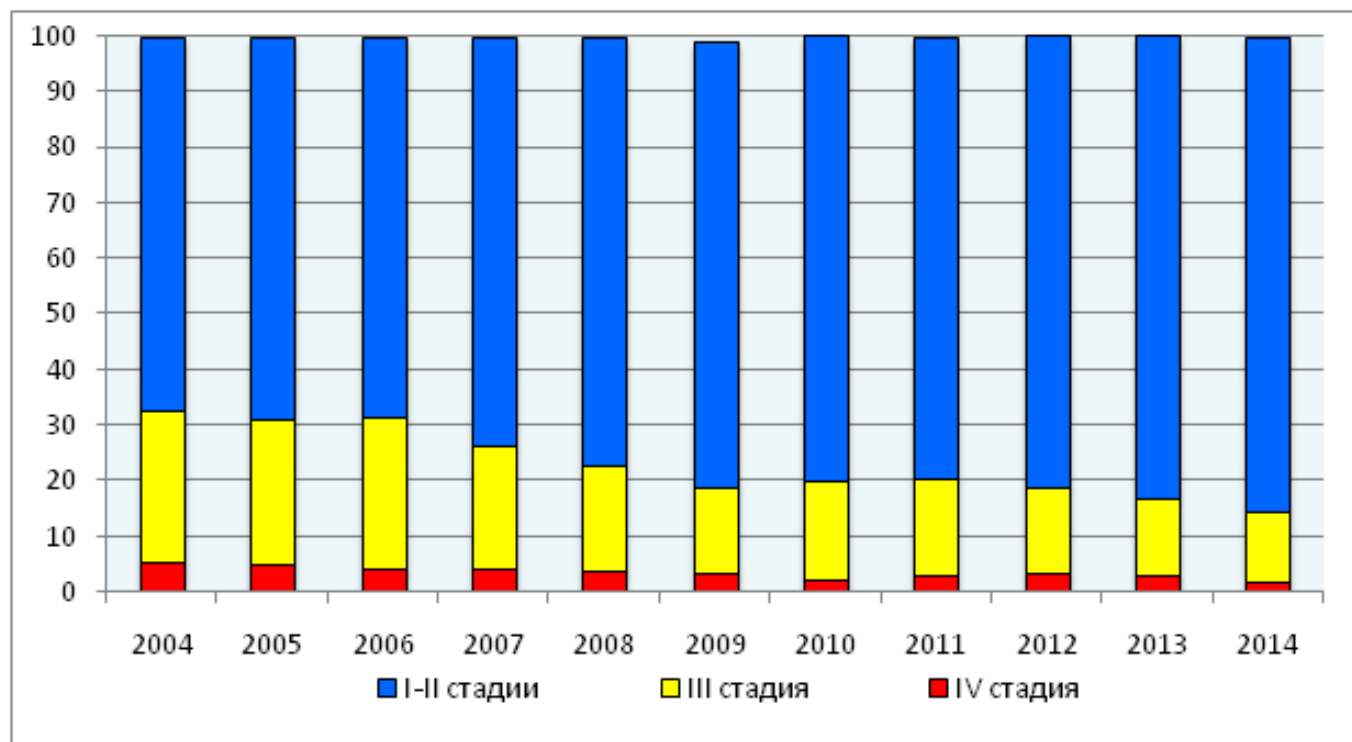


Рисунок 4 - Удельный вес I-II, III и IV стадий вновь выявленных случаев злокачественных новообразований яичников населения Республики Казахстан (%)

В таблице 6.2 представлены основные статистические показатели, характеризующие состояние онкологической помощи пациенткам со злокачественными новообразованиями шейки матки. Отмечается увеличение числа вновь зарегистрированных пациентов в 2014 году по сравнению с 2008 годом на 29,2 %, что составило 1770 пациентов. Диагноз был подтвержден морфологически в 2014 году в 96,3% случаев. Согласно данным канцер-регистра в 2014г 82% женщин были выявлены на ранних стадиях, из них 23% были выявлены при профосмотрах. Отмечается заметное увеличение выявления рака шейки матки в начальных стадиях в 2014 году по сравнению с 2008 годом на 6,68%, что связано с эффективной работой скрининговой программы. Тем не менее остаются высо-

кими показатели одногодичной летальности, за 2014 год показатель одногодичной летальности составил 2,06%, однако можно заметить небольшое снижение данного показателя по сравнению с 2008 годом на 6,4 %.

Вместе с тем остается низким процент пациентов подлежащих радикальному лечению, в 2014г составил 68,5 %, что нельзя признать удовлетворительным при современном развитии здравоохранения. Нужно отметить резкое снижение отказов пациенток от лечения в 2014 по сравнению с 2008г на 2,33% и составил 0,67% из вновь заболевших. Также отмечается заметное снижение общих противопоказаний к проведению специализированного лечения на 2%.

Таблица 2 - Основные статистические показатели. Злокачественные новообразования шейки матки

Показатель	2008	2014
Число вновь выявленных случаев заболевания	1253	1770
Заболеваемость на 100 000 населения (грубый интенсивный показатель)	15,5	20,2
Заболеваемость на 100 000 населения (стандартизованный WORLD показатель)	14,9	19,4

Диагноз установлен в I и II стадии заболевания (% к выявленным случаям)	76,2	82,88
Выявлено при профосмотрах с I и II стадией заболевания (в %к числу всех вновь выявленных случаев)	26,81	23
Подтверждено морфологически (% к вновь выявленным случаям)	99,5	96,32
Прожили менее года с момента установления диагноза из числа зарегистрированных в предыдущем году (одногодичная летальность в %)	2,7	2,06
Получили лечение по радикальной программе (% к вновь выявленным случаям)	65,4	68,5
Отказались от лечения (% из числа вновь заболевших)	3	0,67
Имели противопоказания к лечению (% из числа вновь заболевших)	3	1,01
Умерло от злокачественных новообразований	623	689
Смертность на 100 000 населения (грубый интенсивный показатель)	7,7	7,8
Смертность на 100 000 населения (стандартизованный WORLD показатель)	7,3	6,6
Отношение смертности к заболеваемости в % (интенсивные показатели)	49,7	38,6
Отношение смертности к заболеваемости в % (стандартизованные показатели)	49	34
Число пациентов, состоящих на учете на конец года	9471	11111
Из них состоящих на учете 5 лет и более	5774	6020

Тем не менее, период с 2004 года по 2014 годы характеризовался определенными успехами в улучшении медицинской помощи женщинам со злокачественными

новообразованиями шейки матки, о чем говорит снижение отношения смертности к заболеваемости с 52,4‰ до 38,4‰.

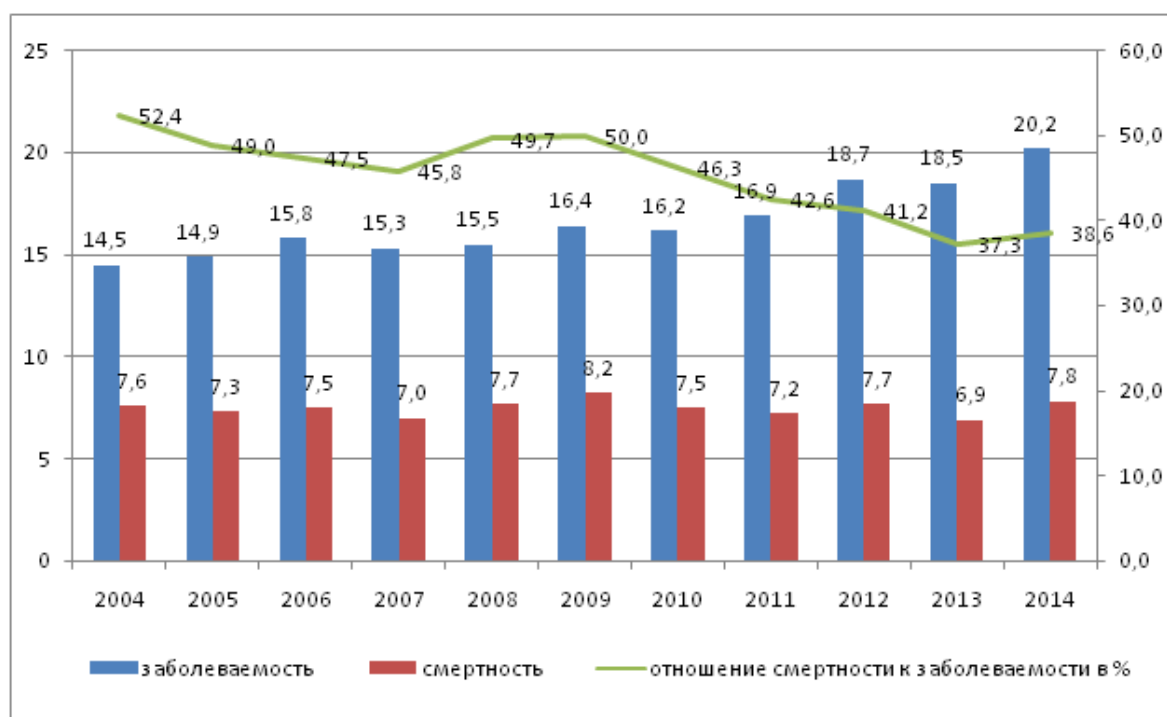


Рисунок 5 - Злокачественные новообразования шейки матки: заболеваемость, смертность (грубые интенсивные показатели на 100 000 женского населения Республики Казахстан), отношение показателей смертности к заболеваемости (%)

Отмечается незначительное увеличение наблюдаемых диспансерами пациенток в 2014г, 11 111, из которых 54,18 % состоят на учете 5 лет и более.

Таким образом, анализ распространенности РШМ как в целом по Республике, так и по регионам показал рост заболеваемости этой онкопатологией среди женского

населения. Отмечается заметное увеличение выявления рака шейки матки в начальных стадиях в 2014 году во втором пятилетнем периоде по сравнению впервым пятилетним периодом, что связано с эффективной работой скрининговой программы.

Список литературы

1. World Health Organization. International Agency for Research on Cancer . Globocan 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012.

2. Ferlay J., Soerjomataram I., Dikshit R. et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012 //Int. J. Cancer.- 2015.- Vol.136, N5.-S.59–86.10.1002/ijc.29210.

3. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байнеусов Д.М.

исоав. Показатели онкологической службы Республики-Казахстан за 2011 год.- Алматы. – 2012. – 108 с.

4. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и соавт. Показатели онкологической службы Республики-Казахстан за 2008 год. - Алматы. – 2009.

5. Применение методов статистического анализа: учебное пособие / Под ред. Кучеренко В.З.- М., 2004. – 188 с.

Тужырым

Қ.Ш. Нургазиев., А.Ж. Жылқайдарова, М.Р. Қайрабаев,
Р.О. Болатбекова

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Summary

K.Sh.Nurgaziev, A. Zh. Zhylkaydarova, M.R. Kairbaev,
R.O. Bolatbekova

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology,
Almaty

2004-2014 жж аралығында Қазақстан Республикасындағы жатыр мойыны қатерлі ісігінен ауыру және өлім көрсеткіші

Соңғы 10 жыл аралығында жатыр мойыны қатерлі ісігімен ауру көрсеткіші бағаланды. Жатыр мойыны қатерлі ісігінің аймақтық, уақтылы және жастық ерекшеліктерін 100 мың әйелге шаққанда жастық интенсивті және стандартизацияланған көрсеткішпен есептелді. World әлемдік стандарты көрсеткішімен сәйкестендіргенде Қазақстан Республикасында ауыру көрсеткіші 100 мың әйелге шаққанда 17%000 – 20%000 құрайды. 2004ж ауру көрсеткіші 14,5 100 000 әйел адамға, 2014ж 20,2 100 000 әйел адамға. Ауыру шыңы көрсеткіші соңғы 6 жыл бойына жас әйелдер қатарына ауысуда, ауру көрсеткішінің жоғарылауын 35 және 55 жас аралығындағы әйелдер құрайды. 2004 – 2014 жж аралығында жатыр мойыны қатерлі ісігі стадиялық анализінде бірінші стадияның анықталуы жоғарылауда.

Түйінді сөздер: жатыр мойыны қатерлі ісігі, ауыру, өлім, Қазақстан Республикасы.

The estimation of incidence and mortality from cervical cancer in the Rthublic of Kazakhstan for 2004-2014

We estimate incidence of cervical cancer over the last 10 years. Territorial, time and age characteristics of cervical cancer were studied by age intensive and standardized to 100 thousand female population. In the Republic of Kazakhstan incidence rates range from 17% to 20% 000 female population. In 2004, incidence rates were 14.5 per 100 000 female population, and in 2014 were 20.2 per 100 000 female population. The peak incidence over the last 6 years has shifted to a younger age. In the analysis of cervical cancer in the context of the stages marked increase in the detection rate of the disease in the first stage from 2004 to 2014

Key words: cervical cancer, incidence, mortality, the Republic of Kazakhstan.